

3^ο Βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός (Πλήρης)

- Χαρακτηρίζεται από την ανεξάρτητη ενεργότητα του κόλπου (P) και των κοιλιών (QRS). Δεν υπάρχει αγωγή μέσω του κολποκοιλιακού (κ-Κ) κόμβου και έτσι κανένα κολπικό ηλεκτρικό ερέθισμα (κύμα P) δεν καταφέρνει να περάσει προς τις κοιλίες.
- Οι κοιλίες βηματοδοτούνται από κάποιο έκτοπο κέντρο στον κ-Κ κόμβο (συνήθως με 45-60 σφύξεις/λεπτό) ή από κάποιο έκτοπο κέντρο υποκομβικά (με 30-40 σφύξεις/λεπτό) με ρυθμό βραδύτερο κι ανεξάρτητο από αυτόν των κόλπων, αλλά σχετικά σταθερό.



- Ο αποκλεισμός εντός του κ-Κ κόμβου εμφανίζεται συνήθως με φυσιολογικά (στενά) συμπλέγματα QRS και συχνότερα οφείλεται σε κατώτερο OEM, τοξικό δακτυλιδισμό, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα και συχνά είναι παροδικός.
- Ο υποκομβικός αποκλεισμός (εντός των κοιλιών) συνοδεύεται από ευρέα συμπλέγματα QRS και συνήθως εμφανίζεται σε πρόσθιο εκτεταμένο OEM ή σε σοβαρή σκληρο-εκφυλιστική νόσο του συστήματος αγωγιμότητας (αμυλοείδωση, νόσος Lenegre, κ.ά.).
- Ασθενείς με πλήρη κ-κ αποκλεισμό μπορεί να παρουσιάζουν ήπια ή θορυβώδη σημεία εγκεφαλικής και ιστικής υποάρδευσης, όπως συγκοπτικά επεισόδια, στηθάγχη, ζάλη, τάση για λιποθυμία, διαταραχές όρασης, δυσφορία, αδυναμία, παγωμένα άκρα, κ.λπ.
- ★ Σε ποσοστό 15-30% των ασθενών η αρρυθμία εντοπίζεται λόγω της εμφάνισης κρίσεων **Adams - Stokes**. Οι κρίσεις αυτές είναι συγκοπτικές, οι οποίες οφείλονται σε ισχαιμία του εγκεφάλου και χαρακτηρίζονται από απώλεια συνείδησης, ωχρότητα του προσώπου και, εάν διαρκούν άνω των 15 sec, κυάνωση, βαθειά ρεγχώδη αναπνοή και σπασμούς. Οι συγκοπτικές κρίσεις που διαρκούν πάνω από 60 sec είναι συνήθως θανατηφόρες.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Απαιτεί άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση, διότι μπορεί να μεταπέσει σε ασυστολία.
2. Τοποθετούμε 3-way φλεβική γραμμή και χορηγούμε 0,5-1,0 mg **Ατροπίνη** iv-bolus, που επαναλαμβάνεται ανά 3-5 λεπτά, μέχρι τη μέγιστη δόση των 3 mg (3 amp.) ενδοφλεβίως.
3. Χορηγούμε O₂ (3-8 lt/min), με ρινική κάνουλα ή μάσκα Ventouri (στόχος SpO₂ > 94%).
4. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση Ατροπίνης, χορηγείται **Ισοπροτερενόλη**, ήτοι 5 amp. Isuprel / Isoprenaline 0,2 mg/ml, εντός 250 ml D₅W ή N/S, με ροή στις 10-30 μικροσταγόνες ανά λεπτό, αναλόγως της κλινικής ανταπόκρισης. Επί υποδόριας ή ενδομυϊκής χορήγησης, η αρχική δόση είναι 0,2 mg (1 amp. Isuprel).
5. Συνήθως, οι ασθενείς με υποκομβικό αποκλεισμό (ευρέα QRS), δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση Ατροπίνης και Ισοπροτερενόλης. Σε αυτούς, καθώς και σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς (με κλινικά σημεία ή συμπτώματα ιστικής υποάρδευσης) επιχειρούμε **εξωτερική διαδερμική βηματοδότηση**, μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο.

Η ένταση της διαδερμικής βηματοδότησης πρέπει να αυξάνεται σταδιακά, από 0 mA μέχρι το ελάχιστο σημείο που μπορεί να επιτευχθεί βηματοδότηση, δηλαδή μέχρι εντάσεως 50-80 mA. Η ήπια καταστολή για τη βηματοδότηση επιτυγχάνεται με Λοραζεπάμη (1-2 mg Tavor, iv) ή με Διαζεπάμη (10-20 mg Stedon, iv) και η αναλγησία επιτυγχάνεται με 2-4 mg Μορφίνη (iv). Εναλλακτικά, αντί της Λοραζεπάμης ή της Διαζεπάμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί Μιδαζολάμη (Dormicum, iv), χορηγώντας αρχικώς ½ amp. των 5 mg / 5 ml και με δόσεις τιτλοποίησης: 1 mg, έως συνολική δόση: 3,5-7 mg για άτομα < 60 ετών χωρίς σοβαρή συννοσηρότητα.
6. Άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο – συνοδεία ιατρού και πάντοτε υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, σφύξεις και SpO₂) – όπου ίσως χρειαστεί μόνιμη καρδιακή βηματοδότηση.